הקבלה במרפאת טרום ניתוח

מה כותבים, איפה ואיך · תדרוך לסטאז׳רים ולמתמחים

על קוד של מתמחה
מציינים שהקבלה נכתבה על ידכם, כולל שם הסטאז׳ר/ית.

כל נושא ברובריקה שלו
בקמיליון: תרופות תחת תרופות, ניתוחים תחת ניתוחים.

לא משאירים לאשפוז
התורן בלילה עמוס. סוגרים הכול בטרום, כולל אק״ג.

בדיקה חסרה?
פקס למזכירת המחלקה: **08-9441790**

בסוף
מדפיסים וחותמים.

1 תלונה עיקרית

הופנה לניתוח _____ בשל _____ (האינדיקציה).

דוגמה: כריתת כיס מרה בגישה לפרוסקופית בשל אירועים חוזרים של דלקת.

2 מחלה נוכחית

- פותחים ב: **בן/בת XX, סובל/ת מ...** ומחלות הרקע בכותרות. הפירוט בהמשך.
- הדמיה (CT, MRI): עיקרי הפענוח עם תאריך. רק מה שרלוונטי, בלי העתק־הדבק.
- יש גרורות מרוחקות? **מדברים עם המתמחה.**
- ממצאי הבירור לפי סדר כרונולוגי.
- מי הכירורג שהפנה ומה האינדיקציה.
- מבקשים סיכום מרופא המשפחה. חוסך זמן בתרופות ובמחלות הרקע.

3 מחלות רקע: מפורט ויסודי

- **מחלת לב איסכמית:** צנתורים, אילו עורקים, מתי ואילו תרופות. אישור קרדיולוג לסיכון הניתוחי ולהפסקת נוגדי קרישה.
- **פרפור פרוזדורים:** הטיפול הקבוע. **אירוע מוחי:** מתי ומה.
- **מחלת ריאות:** סיכום רופא ריאות והתייחסות לסיכון.
- בכל מחלה: יש ייעוץ? מה הוא אומר? חסר ייעוץ? מציינים.
- עוברים על כל התיק ומכניסים את כל הייעוצים.

4 בדיקות טרום ניתוח

טבלת הבדיקות הנחוצות בסביסטון ונהלי המחלקה. הכול מ-3 החודשים האחרונים.

אק״ג	מפרטים. אין, או באיכות לא טובה? עושים שוב.
צילום חזה	אין פענוח? מסתכלים וכותבים. **יש CT חזה? לא צריך צילום.** מציינים ברובריקה.
דם	המוגלובין, טסיות, לויקוציטים, קריאטינין, Na, K, INR. לפי הצורך: סמנים, אלבומין, מדדי דלקת. תאריך ברובריקה.
לא עדכני?	מכתב לרופא המשפחה עם הבדיקות. המטופל מגיע איתן ליום הניתוח.

5 ניתוחים בעבר

- מתי, איזה ניתוח ובאיזה חתך (למשל אפנדקטומי לפרוסקופי או מקברני).
- לא ברשימה? כותבים "לטיפול הרשמת" ואת שם הניתוח בהערות.

6 תרופות קבועות

- **דיוק! מוודאים מול המטופל ומול הרשומות.**
- מינון, תדירות ודרך מתן.
- נוגדי קרישה (אספירין, קומדין, פלביקס, קלקסן ודומיהם): מתי הופסקו ולמה ניתנים.
- מסבירים למטופל מה ממשיכים ומה מפסיקים.

והכי חשוב: מפעילים שיקול דעת ושואלים את המתמחה בכל שאלה.

7 מה מוסיפים לפי תחום

בקעים

- לפי מכתב ההפניה: איזה בקע, איזה תיקון ומה האינדיקציה.
- בדיקה: שני הצדדים והטבור. צלקות קודמות. בגברים גם אשכים.
- שואלים על מתן שתן ונוקטוריה.
- בקע בצלקת: אילו ניתוחים ומתי.

בריאטריה

- מדד מסת גוף (BMI), מחלות רקע ואינדיקציה. עוברים על כל המפגשים במרפאה הבריאטרית.
- שיקוף בליעה, גסטרוסקופיה ו-TSH.
- בדיקות דם: ויטמינים, פריטין ועוד.
- ניתוח קודם כמו טבעת: לציין את הסוג (LAGB, SRVG).

שד

- מרפאת השד או מכתב ההפניה: אפיון הגידול ואינדיקציה.
- **צד ימין או שמאל: חשוב!**
- כרונולוגיה: פתולוגיה, סמנים, סימון מתוכנן (איזוטופים או תיל).
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי, בדיקה גנטית ושיתוף פלסטיקאים.

קולון

- הערות המנתח.
- בירור סיסטמי: CT, צילום חזה, PET CT לפי הצורך.
- קולונוסקופיה ו-TRUS אם יש. פתולוגיה (כולל MMR), סמנים ו-MRI.
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי והשיפור אחריו.

הפטוביליארי

- איזה ניתוח, התייצגות וסיבת הבירור.
- הבירור המקומי והסיסטמי לפי תאריכים. EUS ו-MRI: יחס לכלי דם.
- פתולוגיה ומרקרים. ניקוז דרכי מרה או ERCP.
- מעבדה: גם אנזימי כבד ובילירובין.

קיבה

- תוצאות גסטרוסקופיה ופתולוגיה.
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי.
- תוצאות הבירור הסיסטמי (CT).

✓ לפני שמדפיסים

- ☐ תלונה עיקרית: ניתוח + אינדיקציה
- ☐ מי הכירורג שהפנה
- ☐ הבירור לפי תאריכים
- ☐ כל מחלות הרקע עם הייעוצים
- ☐ אק״ג, צילום חזה (או CT) ודם מ-3 חודשים
- ☐ כל ניתוח ברובריקה שלו, עם חתך
- ☐ תרופות: מינון, תדירות ודרך
- ☐ נוגדי קרישה: מתי הופסקו
- ☐ הוסבר למטופל מה ממשיכים
- ☐ נכתב ע״י: שם הסטאז׳ר/ית
- ☐ אין שום דבר שנשאר לאשפוז
- ☐ הודפס ונחתם

בעמודים הבאים

שלוש קבלות לדוגמה, כתובות לפי ההנחיות. לצד כל אחת: מה בדקנו ולמה.

1. **בקע מפשעתי** — תיקון לפרוסקופי עם רשת
2. **בריאטריה** — OAGB אחרי טבעת
3. **קולון** — כריתת סיגמואיד

קבלות לדוגמה · 1 מתוך 3

כריתת כיס מרה

מקרה 1 · מטופלת בת 50, ניתוח אלקטיבי.

המרכז הרפואי קפלן
מרפאת טרום ניתוח · המערך הכירורגי

קבלה רפואית

שם המטופל: **[מטופל לדוגמה]**	ת.ז.: **000000000**	גיל: **50**	תאריך: ___/___/____

פרטים	בת 50, אלקטיבית לניתוח כריתת כיס מרה.
רקע רפואי	סכרת סוג 2, דיסליפידמיה.
רגישות לתרופות	פניצילין (פריחה).
תרופות קבועות	• LITROVA • METFORMIN
נוגדי קרישה	ללא טיפול במדללי דם.
רקע ניתוחי	• לידה קיסרית, 2010.
מחלה נוכחית	• אשפוז במחלקה כירורגית ב-08.2026, בתמונה של דלקת כיס מרה. קיבלה טיפול שמרני. שוחררה עם המלצה להשלמת MRCP לפני ניתוח. • אולטרסאונד בטן הדגים: כיס מרה עם אבנים בתוכו, עיבוי דופן, לא הודגמה הרחבה בדרכי מרה. • במעבדה הייתה הפרעה באנזימי כבד: GGT 220 וכן ALKP 150. • בתאריך 15.09.2026 בוצע MRCP: כיס מרה ללא סימני דלקת, עם אבנים בתוכו, דרכי מרה לא מורחבות, לא הודגמו אבנים בדרכי מרה.
הערכה טרום ניתוחית	• צילום חזה 01.10.2026: לא הודגם תפליט, תסנין או גודש. • אק״ג 01.10.2026: קצב סינוס סדיר, ללא ממצא חריג. • מעבדה 01.10.2026: ללא ליקוציטוזיס, המוגלובין 14, טסיות 210 אלף. קריאטינין תקין, אלקטרוליטים בדם תקינים, בילירובין תקין, אנזימי כבד תקינים. המוגלובין מסוכרר HbA1C 5.5%, תפקודי קרישה INR 1.
בדיקה גופנית	• ריאות: כניסת אוויר טובה ושווה דו״צ. • לב: קולות לב סדירים, לא נשמעו אוושות. • בטן: רכה, לא רגישה. צלקת ניתוחית רוחבית בבטן תחתונה. לא נמששו בקעים בדופן הבטן. • גפיים: ללא סימני DVT.
הערכת מרדים	יש אישור לניתוח, ללא המלצות מיוחדות.
תכנית	**לניתוח בהצלחה.**

לדוגמה בלבד

נכתב ע״י: סטאז׳ר/ית [שם] על קוד של ד״ר [שם]

הודפס ונחתם ✓

קבלות לדוגמה · 2 מתוך 3

תיקון בקע מפשעתי ימני

מקרה 2 · מטופל בן 76, ניתוח אלקטיבי בגישה פתוחה, עם רקע לבבי ונוגדי קרישה.

המרכז הרפואי קפלן
מרפאת טרום ניתוח · המערך הכירורגי

קבלה רפואית

שם המטופל: **[מטופל לדוגמה]**	ת.ז.: **000000000**	גיל: **76**	תאריך: ___/___/____

פרטים	בן 76, אלקטיבי לתיקון בקע מפשעתי מימין בגישה פתוחה.
רקע רפואי	יתר לחץ דם, אי ספיקת לב, מחלת לב איסכמית (עבר 3 צנתורים, האחרון ב-2023), פרפור פרוזדורים, סכרת, תת פעילות של בלוטת התריס, מצב אחרי ממאירות בערמונית.
רגישות לתרופות	לא ידוע על רגישות לתרופות.
תרופות קבועות	• Losartan • Concor • Fusid • Forxiga
נוגדי קרישה	נוטל אליקוויס (Apixaban).
רקע ניתוחי	• 2010: תיקון בקע מפשעתי משמאל בגישה פתוחה, עם הנחת רשת. • 2022: כריתת ערמונית בגישה פתוחה. • כריתת תוספתן בגישה פתוחה, בגיל 22.
מחלה נוכחית	נבדק במרפאה כירורגית ע״י ד״ר [שם] ב-08.2026. סובל מכאב במפשעה ימין תקופה ארוכה. בבדיקתו: בקע מפשעתי ימני, אינגווינוסקרוטלי, חוזר בקלות. ללא בקע משמאל. הופנה לניתוח תיקון בקע בגישה פתוחה.
הערכה טרום ניתוחית	• הערכת קרדיולוג, ד״ר [שם], 05.08.2026: אין מניעה מבחינה לבבית לניתוח תיקון בקע. יש להפסיק את הדילול (אפיקסבן) 48 שעות לפני הניתוח. • צילום חזה 02.08.2026: ללא תסנין, תפליט או גודש. • אק״ג 02.08.2026: קצב סינוס סדיר, RBBB. • מעבדה 02.08.2026: ללא ליקוציטוזיס, המוגלובין 13, טסיות 156 אלף. קריאטינין 0.7, אלקטרוליטים בדם תקינים. תפקודי קרישה INR 1, המוגלובין מסוכרר HbA1C 6.7%. תפקודי בלוטת התריס (TSH, T3, T4) תקינים.
בדיקה גופנית	• ריאות: כניסת אוויר טובה ושווה דו״צ. • לב: קולות לב סדירים. • בטן: רכה, לא רגישה. בקע מפשעתי אינגווינוסקרוטלי מימין, חוזר בבדיקה. לא נמשש בקע משמאל. צלקות ניתוחיות: בבטן תחתונה ימנית (מקברני), בבטן תחתונה שמאלית (תיקון הבקע הקודם) ובבטן תחתונה אמצעית (כריתת הערמונית). • גפיים: בצקת +1 דו״צ, ללא סימני DVT.
הערכת מרדים	מאושר.
תכנית	**הפסקת אליקוויס 48 שעות לפני הניתוח. לניתוח בהצלחה.**

לדוגמה בלבד

נכתב ע״י: סטאז׳ר/ית [שם] על קוד של ד״ר [שם]

הודפס ונחתם ✓

קבלות לדוגמה · 3 מתוך 3

כריתת מעי גס ימני

מקרה 3 · מטופל בן 65, ניתוח אלקטיבי, עקב ממצא בתוספתן אחרי כריתתה.

המרכז הרפואי קפלן
מרפאת טרום ניתוח · המערך הכירורגי

קבלה רפואית

שם המטופל: **[מטופל לדוגמה]**	ת.ז.: **000000000**	גיל: **65**	תאריך: ___/___/____

פרטים	בן 65, אלקטיבי לניתוח כריתת מעי גס ימני, עקב mucinous neoplasm of appendix.
רקע רפואי	יתר לחץ דם.
רגישות לתרופות	לא ידוע על רגישות לתרופות.
נוגדי קרישה	ללא טיפול במדללי דם.
רקע ניתוחי	• 01.09.2026: כריתת תוספתן בגישה לפרוסקופית.
מחלה נוכחית	• אשפוז במחלקה כירורגית ב-01.09.2026 עקב דלקת תוספתן. עבר כריתת תוספתן בגישה לפרוסקופית, במהלך תקין. • בפתולוגיה: mucinous neoplasm of appendix בבסיס התוספתן, עם מעורבות של שול הכריתה. • נבדק במרפאה כירורגית ע״י ד״ר [שם]. הומלץ על ניתוח כריתת מעי גס ימני, ויש להשלים קולונוסקופיה לקראת הניתוח. • קולונוסקופיה 10.10.2026: הבדיקה בוצעה עד הצקום, מעי גס במראה תקין לכל אורכו.
הערכה טרום ניתוחית	• צילום חזה 01.10.2026: לא הודגם תפליט, תסנין או גודש. • **אק״ג: חסר.** • מעבדה 01.10.2026: ספירה תקינה, INR תקין, אלקטרוליטים בדם וקריאטינין תקינים.
הערכת מרדים	**לא מאושר זמנית.** יש להביא אק״ג עדכני ביום הניתוח.
תכנית	• **להשלים אק״ג בקופת חולים.** • הכנת מעי לקראת הניתוח.

לדוגמה בלבד

נכתב ע״י: סטאז׳ר/ית [שם] על קוד של ד״ר [שם]

הודפס ונחתם ✓